Annexe 1 MAJ N°1 en date du 01/07/2017
Cas ne justifiant pas un contact avec la coordination médicale

I - Le chef d'agrès ne contacte pas la coordination médicale en vue d'un bilan dans les cas qui suivent (cas 1 à 12) :

1. Absence de personne sur les lieux de l'intervention en dehors du cas où l'ordre de départ précise « équipe médicale au départ » lors d'une procédure rouge ou orange (le contact permet d'arrêter le renfort médicalisé) ;

~~2. Décès certain en dehors du cas où l'ordre de départ précise « équipe médicale au départ » lors d'une procédure rouge ou orange (le contact permet d'arrêter le renfort médicalisé) ;~~

3. Il ne s'agit pas d'une victime (selon la définition du chapitre 1) ;

4. Crise de spasmophilie ou de tétanie chez une victime ayant déjà ce type d'antécédents, sans signe respiratoire hormis une fréquence respiratoire élevée, sans facteur de risque ou antécédent cardiovasculaires, sans signe neurologique, transportée vers une structure médicale ;

5. Ivresse simple (marche possible), chez une victime ne présentant ni trouble neurologique, ni traumatisme et étant soit prise en charge par la police, soit transportée en milieu hospitalier ;

6. Crise convulsive unique chez une victime épileptique connue sous traitement, ayant récupéré un état de conscience normal (score de Glasgow = 15), sans déficit moteur ou sensitif, transportée vers une structure médicale ;

7. Hypoglycémie resucrée chez une victime sans antécédent cardiaque, sans douleur thoracique, sans sueurs persistantes, transportée vers une structure médicale ;

8. Epistaxis non traumatique stoppée (n'avale pas de sang) chez une victime dont le traitement complet est connu et sans anticoagulants (vérifier avec la liste jointe) et qui présente un bilan et des constantes normales. Cette victime peut être laissée sur place sans contact ;

9. Traumatisme simple :

- Suspicion d'entorse du coude, du poignet, d'un doigt, du genou, de la cheville, du pied ;
- Suspicion de fracture simple isolée du coude, de l'avant-bras, du poignet, d'un doigt, du col fémoral, de la jambe, de la cheville, du pied ;
- Suspicion de luxation d'épaule ;
- Plaies simples et contusions de la tête, sauf globe oculaire, sans PCI, sans anticoagulants (vérifier avec la liste jointe) ;
- Autres contusions ;
- Plaies et brûlures simples ;
- Plaies suturables et non délabrantes des membres, sans risque de lésions profondes ;

Ces situations doivent respecter toutes les conditions suivantes :

- EVS < 4 ou EN < 7 ;
- Cinétique faible ;
- Aucun déficit vasculo-nerveux ;
- Pas d'angulation importante ;
- Transport vers une structure médicale ;
- Age > 1 an.

10. Relevage d'une personne impotente transportée. Il doit s'agir d'une chute mécanique accidentelle, sans malaise, avec une durée au sol < 2 heures, sans point de compression ni escarre, sans douleur spontanée, sans déformation, sans signe d'AVC même transitoire (AIT) ;

11. Relevage d'une personne impotente laissée sur place sans contact. Il doit s'agir d'une chute mécanique accidentelle, sans malaise, avec une durée au sol < 2 heures, sans point de compression ni escarre, sans douleur spontanée, sans déformation, sans signe d'AVC même transitoire (AIT), sans signe respiratoire. La marche doit être possible sans douleur, les constantes strictement normales, le traitement complet connu, sans anticoagulant (vérifier avec la liste jointe) ;

12 Brancardage ;

Cette procédure est soumise aux conditions suivantes :

- Réalisation impérative d'un bilan complet ;
- Réalisation des gestes de secours appropriés ;
- Transport vers une structure médicale, sauf dans les cas 8 et 11 où elle peut être laissée sur place.

Les cas suivants doivent, quant à eux, faire l'objet d'un contact obligatoire :

- Présence de victimes non prises en compte par une équipe médicale sur les lieux.
- Toute victime refusant ou ne nécessitant pas un transport à l'exception des cas 2 (décès certain), 8 (épistaxis non traumatique stoppée), et 11 (relevage LSP).
- Toute case rouge cochée sur la fiche bilan excepté pour les cas :
  - 4 : fréquence respiratoire > 20 ;
  - 6 : PCI cochée, PAS souvent > 170 mm Hg et PAD souvent > 110 mm Hg et FC souvent > 100 au début de l'intervention ;
  - 7 : glycémie capillaire < 4,4 mmol/l ;
  - 9 : EVS > 3 ou EN > 5 pour les traumatismes des membres.
- Tout départ dans le cadre d'une procédure rouge ou orange s'il n'y a pas d'équipe médicale au départ ;
- En cas de doute ou en présence de tout signe d'aggravation durant l'intervention.

II - Après avoir finalisé le bilan et lorsque l'attente au téléphone a dépassé 10 minutes après composition du numéro non urgent, il est permis aux chefs d'agrès de transporter en interrompant l'appel (cas 13) :

13 Attente téléphonique supérieure à 10 minutes. Ce cas est soumis à plusieurs conditions :

- Contact non urgent (les demandes d'équipe médicale, les détresses avérées, les douleurs thoraciques typiques,
- les AVC… sont donc exclus) ;
- Procédure blanche ou retour de procédure verte ;
- Cas relevant d'un transport vers un SAU ;
- Pas de douleur thoracique ;
- Pas de trouble respiratoire.

Liste des Anticoagulants

Comprimés	Principes actifs	Injectables	Principes actifs
Coumadine®	warfarine sodique	Calciparine®	héparine calcique
Eliquis®	apixaban	Fragmine®	daltéparine sodique
Lixiana®	édoxaban tosilate	Fraxodi®	nadroparine calcique
Minisintrom®	acénocumarol	Heparine®	héparine sodique
Pradaxa®	dabigatran étexilate mésilate	Innohep®	tinzaparine sodique
Préviscan®	fluindione	Lovenox®	énoxaparine sodique
Sintrom®	acénocoumarol	Orgaran®	danaparoïde sodique
Xarelto®	rivaroxaban		

Aucun élément des cadres ℹ ne peut faire l'objet de contrôle, d'évaluation ou de questions d'examen.